

Exposición narrativa gradual

Fase de procesamiento del trauma—solo después de estabilización (Herman, fase 2)

CUÁNDO INDICAR

Cuando el paciente ya cuenta con regulación emocional básica, red de seguridad activa y no hay riesgo agudo sin contener. No se indica mientras haya ideación suicida activa, consumo problemático sin abordar, o ausencia total de vocabulario emocional

OBJETIVO DE LA TÉCNICA

Que el recuerdo traumático pase de ser un fragmento evitado, cargado de vergüenza y nunca puesto en palabras completas, a integrarse como una narrativa coherente con principio, desarrollo y fin — reduciendo así su carga intrusiva y la evitación asociada.

PROCEDIMIENTO SUGERIDO — EN CAPAS, NO DE UNA VEZ

1. Primera narración, libre y breve

Permitir que cuente lo que ya contó espontáneamente, sin forzar detalle. Validar el coraje de haberlo dicho. No pedir ampliación todavía.

2. Psicoeducación del congelamiento

Antes de profundizar, explicar la respuesta de congelamiento como reacción biológica normal ante amenaza sin posibilidad de huida o lucha — clave para reducir la autculpa (“no me defendí”).

3. Segunda narración, con más detalle sensorial

En una sesión posterior, pedir que agregue detalles concretos: dónde estaba, qué vio, qué escuchó, qué sintió en el cuerpo. El ritmo lo marca la activación del paciente, no un guion fijo.

4. Tercera narración, con foco en significado

Una vez que el relato es más estable, trabajar qué significó el evento para él entonces y qué significa hoy — apuntando a separar la creencia generalizada del evento puntual.

5. Chequeo de activación en cada paso

Antes y después de cada narración, medir activación (0-10). Si supera un umbral que el paciente no puede regular, volver a herramientas de estabilización antes de seguir.

CLAVE CLÍNICA

No avanzar de capa si el paciente no tiene aún manejo de la activación corporal.